EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 74149
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-15 15:23:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE ALBERTO HERNANDEZ SEPULVEDA			RUN	: 7.530.178-2
F.Nac	: 20-06-1941	Edad	: 82 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: NINQUIHUE EL PERAL ACT			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-10	Fecha Egreso	: 2023-11-15 15:23:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I82-OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Tromboembolismo pulmonar en ramas segmentarias para el lobulo medio e inferior derecho PESI score 82 Riesgo bajo
HTA sistemica no tratada
FA con RVA
Cardiopatia dilatada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I26-EMBOLIA PULMONAR. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE MASCULINO CON ANTECEDENTES DE HTA SISTEMICA NO TRATADA QUIEN REFIERE INICIO DE CUADRO CLÍNICO EL DÍA DE AYER EN HORAS DE LA TARDE CARACTERIZADO POR DISNEA SUBITA ASOCIADO A COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL Y DOLOR EN REGIÓN COSTAL IZQUIERDA POR LO QUE ES TRAIDO AL SU HSC DONDE VALORAN ENCONTRANDO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES OBJETIVAN EN MONITOR FARVA POR LO QUE SOLICITAN LABORATORIOS ENCONTRANDO DIMERO D ELEVADO (4865) Y POSTERIORMENTE ANGIOTAC TORAX QUE OBJETIVA HALLAZGOS DE TEP EN RAMAS SEGMENTARIAS POR LO QUE INGRESAN , ES EVALUADO Y SE AUTORIZA INGRESO AL SERVICIO DE MEDICINA.
PACIENTE INICIA TTO ANTICOAGULANTE CON ENOXAPARINA 80MG C/ 12 HRS SC. MAS TTOS ANTIHIPERTENSIVOS, EVOLUCIONA ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, SIN REQUERIMIENTO DE O2 ADICIONAL, SE REALIZA AYER 14/11 TRASLAPE A NOACS (ANTICOAGULANTE ORAL) CON DABIGATRAN 110MG C/12 HRS CON BUENA RESPUESTA, HOY EN BCG, SIN APREMIO VENTILATORIO AFEBRIL, HDN ESTABLE, POR LO QUE SE PLANTEA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA TTO ATB EV Y KINE M Y R, MAS SEGUIMIENTO DEL CUADRO CLINICO.

PLAN DE MANEJO:

CONTROL POLI MED INTERNA LUEGO DE 15 DIAS DE ALTA HODOM (CONTROLAR Y EVALUAR ESTUDIO CAUSAS TEP, CONTINUIDAD TTO TACO)
CONTROL URGENCIAS SOS

INDICACIONES AL ALTA

1. HOSPITALIZACION DOMICILIARIA
2. REPOSO RELATIVO, LEVANTAR POR KINE O ASISTIDO SEGÚN EVOLUCIÓN
3. RÉGIMEN HIPOSODICO
4. KINE M Y R x 2
5. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 7 dias via ENDOVENOSA

6. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS, 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
7. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS, 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS, 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. DABIGATRAN 110 MG UNIDAD UNIDAD, 1 unidad cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
10. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS, 2 comprimido cada 8 hrs. por 4 dias via ORAL, SOS SI DOLOR O FIEBRE

EXÁMENES Y RESULTADOS

-Ex INGRESO 10/11/2023: leucocitos 13400 HGB 16.9g/dl HTO 49.5% Plaq 176000 creatinina 0.90mg lactato 1.5 sodio 137mmol potasio 4.1mmol dimero D 4885
-ANGIOTAC TORAX 10/11/23: SIGNOS DE TEP EN RAMAS SEGMENTARIAS PARA EL LOBULO MEDIO Y LOBULO INFERIOR DERECHO. HAY SIGNOS DE SOBRECARGA VENTRICULAR DERECHA. CARDIOMEGALIA . SIGNOS DE CONGESTION PULMONAR LEVE.
-TAC TORAX CONTROL 14/11/23: OPACIDADES LOBULOS INFERIORES, DADO ANTECEDENTES SON SUGERENTES DE INFARTOS PULMOLNARES. PROCESO INFLAMATORIO INFECCIOSO NO ES DESCAQRTABLE, SE SUGIERE CONTROLAR. RESTO ESTUDIO SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO